本章数字资源

第二十章 抑郁障碍的全科医学处理

学习提要

- 抑郁障碍是一种常见的情绪障碍，以心境低落、兴趣缺失、自我评价过低等为主要临床表现，严重影响患者的生活质量和社会功能，甚至导致自杀。全科医生作为患者的第一诊治者，应对抑郁障碍有足够的认识和重视，以便做到及时发现和干预。
- 全科医生应掌握有效的工具和方法，对患者的症状、严重程度、自杀风险、功能状态等进行全面和准确的评估，以便制订合理的治疗方案。
- 全科医生需要根据患者的个体情况，选择适当的药物、心理等治疗方法，定期随访，评估疗效和不良反应，调整治疗方案。同时对于重度抑郁障碍患者，应及时转诊至精神科或心理咨询机构，寻求专业的协助。且应对患者进行健康教育，增强患者的自我管理能力，提高患者的治疗依从性和生活满意度。

抑郁障碍作为一种严重的公共卫生问题，在全球范围内已给数亿患者和家庭带来了巨大的痛苦和困扰。因此，及时发现和治疗抑郁障碍，是保障人类健康和幸福的重要任务。

抑郁障碍的临床表现呈现多样性，除了典型的情绪症状，还可能有认知、行为、躯体、社会功能等方面的障碍。同时对于抑郁障碍的诊断和评估，需要综合运用各种工具和方法来判断患者的病情和需求。在治疗方面，抑郁障碍的治疗包括药物治疗、心理治疗、物理治疗等，全科医生需要根据患者的个体情况进行个体化的选择和组合。此外，抑郁障碍的治疗还需要与患者进行有效的沟通和合作，以此提高患者的治疗依从性和自我管理能力。全科医生还要进行健康教育和心理支持，增强患者的自尊和自信，提高患者的生活质量和满意度。

本章旨在介绍抑郁障碍的全科医学处理，希望能够帮助全科医生对抑郁障碍有一个全面和深入的了解，以此提高抑郁障碍的诊治水平，为抑郁障碍患者提供更好的服务和帮助。

抑郁障碍（depressive disorders，DD）是一种以持续的心境低落或情绪消沉为主要表现的心境障碍，可能由多种因素引起，如遗传、生物化学、社会心理等。这些因素导致神经递质分泌减少和/或受体敏感性降低，从而影响个人的情绪和认知功能。其症状主要包括兴趣缺乏、快感缺失、睡眠障碍、疲劳乏力、自卑内疚、自杀观念等，严重者还可能出现幻觉及妄想症状，这不仅会影响个人的身心健康，还会导致社会功能的下降，如学习、工作、人际关系等方面的困难。而自杀是抑郁障碍最严重的并发症，也是中青年人群的第二大死因。

临床病例

主观资料（S）：患者，女性，35岁。因“情绪低落、失去兴趣半年”至全科医学门诊就诊。

【问题1】作为一名全科医生，在接诊上述这类因“情绪低落、失去兴趣”为主诉的患者时，应该如何采集病史呢？

思路1：有无情绪和心境变化。

全科医生应该询问该患者的情绪低落和失去兴趣是从什么时候开始的，持续了多久，每天出现的

NOTES

时间和程度，是否有规律或波动，是否伴有其他精神症状。如："您是什么时候开始感到情绪低落和失去兴趣的？您是一直这样，还是有时候好一些，有时候坏一些？"同时，全科医生应该注意观察患者的面部表情、语音语调、眼神交流等非言语信号，以判断患者的情绪状态。根据该患者的主诉，全科医生可以推测患者的情绪低落和失去兴趣已经持续了至少半年，且可能较为严重，因为她主动来到门诊求助。

思路 2：有无诱因。

全科医生应该询问该患者有无感染、劳累、过敏、药物服用史等可能引起情绪和心境变化的生理因素。如："您最近有没有感冒、发热、过敏等身体不适？您有没有服用过一些药物，比如镇痛剂、抗生素、避孕药等？"此外，全科医生还应该询问患者近期是否发生重大生活事件，如丧失亲人、婚姻不和谐、失业、经济困难等可能引起情绪和心境变化的心理因素。同时全科医生也应该询问患者有无家族史或个人史，如抑郁障碍或其他精神疾病的家族史，或既往是否有过类似的情绪低落或失去兴趣的经历。根据该患者的主诉，全科医生可以推测患者可能没有明显的生理诱因，但可能有一些心理诱因，如工作压力、家庭矛盾、感情失落等，需要进一步探询。

思路 3：是否对工作和生活产生影响。

全科医生应该询问该患者的情绪和心境变化是否影响了她的日常生活和工作，包括是否能正常生活和完成工作任务，是否有社交退缩或孤立，是否有兴趣爱好或娱乐活动，是否有睡眠障碍或食欲改变，是否有性功能障碍或月经紊乱等。如："您的情绪和心境问题是否影响了您的工作效率或质量？您是否还和以前一样和家人、朋友、同事保持联系和交流？您是否还有自己喜欢的事情或活动？"根据该患者的主诉，全科医生可以推测患者的情绪和心境变化已经严重影响了她的日常生活和工作，导致她无法享受生活的乐趣，可能有社交障碍、睡眠障碍、食欲障碍等。

思路 4：有无加重及缓解因素。

全科医生应该询问该患者有无某些情境或环境能使她的情绪和心境变化加重或缓解，以及她是否有采取过一些措施或方法来改善自己的情绪和心境。如："您有没有尝试过和亲友沟通、参与社区活动、进行体育锻炼等方式来改善您的情绪和心境？这些方式对您有没有帮助？"根据该患者"情绪低落、失去兴趣半年"的主诉，全科医生可以推测患者可能没有找到有效的加重或缓解因素，也没有采取过积极的应对策略。

思路 5：有无发病以来一般情况的变化。

全科医生应该询问该患者发病以来的一般情况，包括饮食、睡眠、大小便、体重变化情况，以及家庭支持情况，以评估患者的身体状况和心理状况。如："您发病以来的饮食、睡眠、大小便、体重有没有明显的变化呢？"根据该患者的主诉，全科医生可以推测患者可能有体重减轻、睡眠质量差、食欲缺乏等，也可能缺乏家庭的理解和支持，需要进一步了解。

思路 6：有无诊治的经过。

全科医生应该询问该患者是否曾就诊于其他医疗机构或寻求专科医生的医疗建议，结果如何；是否服用过药物，药物的名称、剂量，效果如何，有无不良反应等，以了解患者的治疗历史和现状。如："您之前有没有去过其他医院或看过其他医生？"根据该患者的主诉，全科医生可以推测患者可能没有接受过专业的精神科诊断和治疗。

知识点

抑郁障碍的流行病学

抑郁障碍是一种严重影响全球人口健康和生活质量的精神疾病。在我国，根据 2021 年的中国精神卫生调查，成人抑郁障碍的终生患病率为 6.8%，12 个月患病率为 3.6%。同时，世界卫生组织（WHO）的报告显示，抑郁障碍已成为世界范围内青少年致病致残的首要原因。另外，抑郁障碍患者的自杀率约为 10%~15%，其中 15%~25% 自杀成功，首次发作后 5 年内自杀率最高。

知识点

抑郁障碍的病因与发病机制

抑郁障碍的病因及发病机制目前尚不清楚，可能涉及多种危险因素的共同影响。

1. 遗传　抑郁障碍的发生有一定的遗传因素，家族研究发现 40%~70% 的抑郁障碍患者有家族史。而抑郁障碍患者的亲属，尤其是一级亲属罹患抑郁障碍的概率比一般人群高 2~4 倍。此外，双生子研究则显示抑郁障碍的遗传率大约为 37%，其中单卵双胎的抑郁障碍共病率约为 50%，而异卵双胎的共病率为 10%~25%。

2. 神经生化及内分泌因素　抑郁障碍患者的神经递质和神经递质相关的神经回路出现了功能或结构上的改变。其包括的假说有 5-羟色胺（5-HT）假说、多巴胺（DA）假说、去甲肾上腺素（NE）假说以及其他涉及神经递质、神经肽、第二信使的假说。另外，许多研究发现，抑郁障碍患者的下丘脑-垂体-内分泌轴［如下丘脑-垂体-肾上腺（HPA）轴、下丘脑-垂体-甲状腺（HPT）轴、下丘脑-垂体-生长激素（HPGH）轴］功能异常，特别是 HPA 轴异常。

3. 脑电生理变化　抑郁障碍患者的脑电图显示，左右脑半球的平均同步振幅与抑郁程度成反比，而且脑电图有明显的侧化特征，右半球的活跃度增加。这种活跃度增加主要集中在额叶区域，尤其是右额叶，可能与抑郁情绪的形成有关。此外，抑郁障碍患者还可能出现脑电诱发电位的波幅减小。

4. 神经影像学改变　通过功能性磁共振成像、单光子发射计算机断层成像等相关影像学检查，可以发现在抑郁障碍患者的大脑中，前额叶的背部和眶部区域、下丘脑、小脑、尾状核、海马和杏仁核等涉及情绪调节的部位，其代谢或脑血流有异常变化。这种变化会受到疾病阶段、药物治疗、患者类型的影响。

5. 神经免疫学因素　在一些接受细胞因子免疫治疗的患者中，可经常观察到抑郁障碍的发生，而使用抗抑郁药可以缓解这些症状。此外一些有免疫系统疾病的患者，如风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等，也常常伴有抑郁情绪。也有动物实验表明细胞因子可以导致动物产生抑郁样行为，而抗抑郁药可以逆转这些行为。因此，免疫功能的异常也可能是抑郁障碍的一个病因。

6. 社会心理因素　应激事件与抑郁障碍的发生关系较为密切，这包括各种负性生活变化、经济困难、社会地位低下等情况。此外，童年经历也会对抑郁障碍的发生产生长期的影响，如亲子分离、家庭不和睦、儿童期虐待等。还有一些抑郁障碍患者往往具有易感的人格特征，如神经质、消极人格等，这些人格特征会增加抑郁障碍的发生风险和严重程度。

知识点

抑郁障碍的典型临床表现

情绪表现、躯体表现和认知表现是抑郁障碍的三大典型临床表现。

1. 情绪表现　患者的心情持续低落，感到沮丧、压抑、无望、无助、无用。此外情绪低落在早晨最重，晚上有所缓解。同时患者对自己的评价很低，对自己的过去和现在都感到自责、自罪。病情严重时，患者会认为生活没有意义，有自杀的念头和行为，有时甚至想要带走亲人。此外，部分患者还会有焦虑、紧张、恐惧等情绪，常常不安、担忧。

2. 躯体表现　患者的食欲和睡眠都会受到影响，多数患者表现为食欲减退、体重下降、睡眠障碍，如入睡困难、睡眠浅、早醒，少数患者表现为食欲增加、体重增加、睡眠过多。部分患者的性欲也会降低，对性生活没有兴趣或快感。除此之外，患者还会感到全身无力、疲乏、动作缓慢，严重者可出现木僵或亚木僵状态。同时也有可能出现便秘、身体各部位的疼痛感、自主神经功能紊乱等躯体症状。

3. 认知表现　患者的思维活动会减慢，言语活动减少、语速慢、语音低。时常自觉脑子变笨

了，思考问题困难，记忆力下降，且注意力也大不如前。此外，患者的决策能力也会降低，变得优柔寡断，犹豫不决。通常抑郁障碍患者的想法会变得非常消极，常常想到死亡或自杀，或者感到痛苦，难以表达。

临床病例（续）

主观资料（S）：患者，女性，35 岁。因“情绪低落、失去兴趣半年”至全科门诊就诊。通过进一步采集病史，了解到以下情况。

现病史：患者自述于半年前开始感到情绪低落，对以前喜欢的事物失去了兴趣，且不愿意与他人交流，常常觉得自己没用，活着没有意义、没有价值，有时甚至想死。患者否认有明显的诱发因素，但表示近期工作压力较大，且与丈夫感情不和，经常吵架。患者并没有寻求过专业的心理咨询或治疗，也没有服用过任何药物。患者近半年的情绪和心境变化对其日常生活和工作造成了严重的影响，因此患者经常请假或旷工，且与同事关系不融洽，致使工作效率下降，家庭责任无法履行。患者自发病以来，神志清楚，精神欠佳，食欲明显减退，睡眠质量很差，入睡困难，且易早醒或多梦，时有便秘，时有腹泻，小便如常，体重下降约 5kg。患者否认有任何躯体不适或精神病性症状。

既往史：否认高血压、冠心病、糖尿病等慢性病病史；否认结核、乙肝及其他传染病病史；无外伤史；无手术史；无输血史；无长期用药史；无食物、药物过敏史；预防接种史不详。

个人史：无饮酒史；吸烟 5 年，每天 10 支，目前未戒烟；无毒物及放射性物质接触史；无冶游史。

婚育史：月经不规律；已婚已育；育有 1 女，体健。

家族史：父母均健在，且无精神疾病史；有 1 个姐姐，有抑郁障碍史。

【问题 2】完成病史采集后，针对该患者，下一步应重点完成哪些体格检查或辅助检查？

由于抑郁障碍可能与躯体疾病或药物有关，因此针对该患者，在排除其他精神疾病后，全科医生还需要进行体格检查或辅助检查，以排除可能引起或加重抑郁障碍的躯体疾病或药物因素。

首先是体格检查，全科医生应重点检查神经系统、内分泌系统、消化系统等方面的异常，如应注意该患者的皮肤黏膜，检查甲状腺是否肿大，以及心率、血压等指标；还有神经系统的感觉、运动、反射、协调等功能是否有异常；如有必要，可进行精神状态检查，以评估患者的认知、情感、思维、意志、行为等方面的障碍。

其次是辅助检查，全科医生应根据该患者的病史和体格检查结果，选择合适的实验室检查或影像学检查，如血常规、尿常规、便常规、血生化、甲状腺功能检测、肾上腺功能检测、垂体功能检测、脑电图、头颅 CT 及 MRI 等。

临床病例（续）

客观资料（O）：

体格检查：体温 36.5℃，脉搏 78 次/分，呼吸 18 次/分，血压 126/84mmHg。常规查体提示皮肤巩膜无黄染，睑结膜及甲床无苍白，浅表淋巴结未触及明显肿大，颈软，甲状腺未触及明显肿大，伸舌居中，瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，双肺呼吸音清，无干湿啰音，心率 78 次/分，律齐，各瓣膜未闻及明显病理性杂音，腹软，全腹无压痛、反跳痛及肌紧张，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常，双下肢无水肿，各关节未见明显肿胀、畸形及压痛，四肢肌力、肌张力正常，全身感觉及深浅反射均未见明显异常。精神状态检查提示：情绪低落，表情呆滞，语言贫乏，回答问题简单而缓慢，自我评价过低，有自责自罪、无价值感等负性认知，有自杀意念但无具体计划和行为。

辅助检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、甲状腺功能检测、肾上腺功能检测、垂体功能检测、脑电图、头颅 CT 及 MRI 结果未见明显异常。

【问题 3】根据上述患者的现病史、体格检查及辅助检查结果，还需要完善哪些其他措施？

思路 1：根据诊断标准进行评估。

根据中国精神障碍分类与诊断标准第 3 版（CCMD-3）的抑郁障碍的诊断标准，结合该患者“半年前开始感到情绪低落，对以前喜欢的事物失去了兴趣，且不愿意与他人交流，常常觉得自己没用，活着没有意义、没有价值，有时甚至想死”等症状；同时伴有“食欲减退、体重下降”等；且排除了器质性精神障碍或精神活性物质和非成瘾物质所致抑郁，可以初步诊断为抑郁障碍。

思路 2：根据抑郁量表进行评估。

根据汉密尔顿抑郁量表（HAMD）的相关内容，结合该患者“悲伤、沮丧”等负面情绪，以及“失去兴趣”等症状，同时伴有“自责、自杀意念”，且合并“睡眠障碍、食欲下降、体重减轻、精神运动性迟滞”等伴随症状，全科医生可初步判断该患者属于中度抑郁障碍。

思路 3：根据自杀风险进行评估。

根据自杀风险评估（SRA）的相关内容，该患者只是偶有自杀的念头，并未出现具体的自杀实际行动，同时该患者存在“与丈夫感情不和、与同事关系不融洽”等社会支持减弱的情况，也未寻求过专业的心理咨询或治疗，因此可初步诊断为低自杀风险。

知识点

抑郁障碍的诊断、评估与鉴别

（一）诊断标准（CCMD-3）

根据中国精神障碍分类与诊断标准第 3 版（CCMD-3）的相关内容，抑郁障碍的诊断标准如下。

［症状标准］以心境低落为主，并至少有下列 4 项。

1. 兴趣丧失、无愉快感。
2. 精力减退或疲乏感。
3. 精神运动性迟滞或激越。
4. 自我评价过低、自责，或有内疚感。
5. 联想困难或自觉思考能力下降。
6. 反复出现想死的念头或有自杀、自伤行为。
7. 睡眠障碍，如失眠、早醒，或睡眠过多。
8. 食欲减退或体重明显减轻。
9. 性欲减退。

［严重标准］社会功能受损，给本人造成痛苦或不良后果。

［病程标准］

1. 符合症状标准和严重标准且至少已持续 2 周。

2. 可存在某些分裂性症状，但不符合分裂症的诊断。若同时符合分裂症的症状标准，在分裂症状缓解后，满足抑郁发作标准至少 2 周。

［排除标准］排除器质性精神障碍或精神活性物质和非成瘾物质所致抑郁。

根据严重程度及有无精神病性症状，可分为轻性抑郁障碍、无精神病性症状的抑郁障碍、有精神病性症状的抑郁障碍。

（二）评估量表

1. 汉密尔顿抑郁量表（HAMD） 是一种由医生或心理专业人员进行的半结构化访谈，共有 17 项或 24 项，每项根据患者的症状和表现给予 0~4 分或 0~2 分的评分，总分越高表示抑郁程度越重。HAMD 是目前使用最广泛的抑郁量表之一，具有较高的信度和效度。

2. 自杀风险评估（SRA） 是一种由医生或心理专业人员进行的结构化或半结构化访谈或问

卷调查，旨在评估患者有自杀的想法或行为的可能性，以及自杀的严重性和紧迫性。根据自杀风险评估的结果，可将患者分为五个等级，具体来说是：①低风险：无望或绝望感，偶尔的自杀闪念；②低-中风险：频繁的想死念头，但无具体计划；③中风险：具体的自杀方式、计划等企图；④中-高风险：防止被发现的措施；⑤高风险：踩点，或已经有过行动。

（三）鉴别诊断

1. 精神分裂症　精神分裂症的阴性症状主要表现为情感迟钝或平淡，自发动作及肢体语言的减少与缺乏，被动退缩等。通常精神分裂症的病程是持续性的，即使在缓解期，也会有残留的精神病性症状。同时精神分裂症患者的认知、情感、意志活动表现为不协调，会出现思维混乱、情感淡漠、意志衰退等，患者缺乏对自己和外界的真实感受，与现实脱节；而抑郁障碍患者则恰好相反。

2. 双相情感障碍　双相情感障碍与抑郁障碍在某种程度上很类似，临床上极易混淆。其中，混合发作则是一种特殊的情况，同时具有抑郁症状和躁狂症状。混合发作的抑郁症状可能与单纯的抑郁发作相似，但混合发作的特点是抑郁症状和躁狂症状同时或快速交替出现，如情绪波动、思维跳跃、言语增多或行为亢奋等。

3. 持久性悲伤障碍　持久性悲伤障碍是一种因亲人或亲密关系的死亡而引起的持久和普遍的悲伤反应，其特征是对逝者的强烈思念和恋念，以及与失去相关的情感痛苦等。持久性悲伤障碍的症状在失去后至少持续 6 个月，严重影响日常功能。持久性悲伤障碍的症状与抑郁障碍的症状有一定的相似性，但是持久性悲伤障碍的症状主要集中在与失去有关的方面，是对失去的正常反应，且有一些是抑郁障碍所没有的，如难以接受失去、难以信任他人、对失去感到痛苦或愤怒等。

4. 器质性精神障碍　器质性精神障碍是由脑部疾病或损伤引起的抑郁症状，而抑郁障碍是由心理或生物因素导致的情绪障碍。两者的临床表现可能相似，如心境低落、兴趣缺失、自责自罪等，但器质性精神障碍的病因是可证实的脑部疾病或损伤，如颅脑外伤、脑肿瘤、脑血管病、颅内感染、脑变性病等。而抑郁障碍的病因是多因素的，包括遗传、环境、生活事件、应激、性格等。

临床病例（续）

初步评估（A）：

结合 CCMD-3、HAMD、SRA 相关诊断标准和评估量表的综合病情评估，该患者目前可以初步诊断为中度抑郁障碍，伴低自杀风险。

【问题 4】作为一名全科医生，针对该患者，接下来应如何制订治疗方案？

该患者目前确诊为中度抑郁障碍，伴低自杀风险。因其之前未服用过药物，故药物治疗上建议首先单一使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂，如帕罗西汀（20mg，每日 1 次）等，急性期首先服用 3 个月，3 个月后观察患者抑郁症状的缓解情况，若患者症状有所好转，则继续进行 4~9 个月的巩固期治疗，药物用法用量同前；若患者症状未见明显好转，或新出现其他不适症状，则考虑增加原始剂量、换药或者加用其他药物。同时嘱患者戒烟，且给予患者心理支持和教育，介绍抑郁障碍的相关知识，鼓励患者积极配合治疗，并定期复诊。

临床病例（续）

处置计划（P）：

根据该患者的抑郁程度和自杀风险，可予以选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂类抗抑郁药物，如帕罗西汀（20mg，每日 1 次），服用 3 个月后观察抑郁症状的缓解情况。

嘱患者戒烟，同时给予该患者心理支持和教育，介绍抑郁障碍的相关知识，鼓励患者积极配合专科治疗，并定期复诊。

【问题 5】作为一名全科医生，针对该患者，应进行哪些方面的健康教育？

思路 1：向患者介绍抑郁障碍的相关知识，包括危险因素、临床表现及预后情况。

思路 2：告诫患者应调整生活作息，适当休息，减轻工作压力，同时遇到问题时可及时与家庭成员沟通，解决问题，倾诉情绪。

思路 3：嘱患者遵医嘱规律服药，不可擅自停药或改变服用剂量，坚持 3 个月的用药疗程后，及时随诊，全科医生根据患者病情变化情况个性化调整治疗方案。

【问题 6】作为一名全科医生，针对该患者，是否需要进行转诊？

目前该患者并不需要转诊，先嘱患者遵医嘱服药，若在治疗时出现其他不适或病情加重的情况，则需要进行转诊，向专业的精神科医生寻求帮助。

知识点

抑郁障碍的基础管理

（一）治疗原则

1. 药物治疗　抑郁障碍后果严重，病程迁延，复发率高，全病程治疗尤为重要。全病程治疗分为三期：急性期治疗（8~12 周）、巩固期治疗（4~9 个月）及维持期治疗（2~3 年）。

急性期治疗（8~12 周）：此阶段的目的是控制症状，达到临床痊愈（无抑郁症状超过 2 周），促进功能恢复，提高生活质量。中重度抑郁发作首选药物治疗，治疗药物应从小剂量开始，逐渐增加至有效剂量，定期评估病情和疗效，如 4~8 周后症状无改善，应调整治疗方案。一般不推荐两种以上抗抑郁药联用，除非是难治性抑郁障碍。

巩固期治疗（4~9 个月）：此阶段的目的是防止疾病复发，维持症状缓解，增强功能恢复。应继续使用急性期治疗有效的药物和剂量，定期评估症状、不良反应、依从性和功能状态。

维持期治疗（2~3 年）：此阶段的目的是防止疾病复发或复燃，保持功能稳定，提高生活质量。有复发倾向的患者，如有 3 次及以上发作史、发病年龄早、有家族史、有残留症状或明显应激因素等，应至少维持治疗 2~3 年。维持治疗期间应定期评估病情和疗效，注意复发的早期征象，监测不良反应。维持治疗结束后，如病情稳定，可缓慢减药至停药；如出现复发征象，应及时恢复原治疗。

常用的药物治疗包括：选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs），代表药物有氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明、西酞普兰和艾司西酞普兰；选择性 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRIs），代表药物有文拉法辛和度洛西汀；去甲肾上腺素和特异性 5-羟色胺能抗抑郁药（NaSSA），代表药物有米氮平；三环类抗抑郁药，代表药物有丙米嗪、氯米帕明、阿米替林、多塞平等。

2. 心理治疗　心理治疗是抑郁障碍治疗的重要组成部分，尤其对有社会心理应激和认知障碍的患者有效。心理治疗相比药物治疗，有更好的长期效果，能降低复发率，提高生活质量。位于一线治疗方案的认知行为治疗可以通过纠正患者的负性思维和行为模式，改善情绪和功能。同时认知行为治疗与抗抑郁药联合治疗，能显著提高临床疗效。

3. 物理治疗　物理治疗是抑郁障碍治疗的重要手段之一，主要适用于药物治疗无效或不能耐受的患者。常用的物理治疗方法包括重复经颅磁刺激、改良电抽搐治疗、经颅直流电刺激等。

（二）针对抑郁障碍患者及其家属的健康教育

抑郁障碍是一种常见的精神障碍，如果能得到及时有效的治疗，可让大部分患者恢复到病前的生活工作状态，因此抑郁障碍并不是罕见的不治之症。

对于抑郁障碍的患者，作为全科医生，首先要向患者充分解释清楚什么是抑郁障碍，常见的临床表现有哪些，可能的危险因素及并发症有哪些，让患者有科学的认识。其次，须告知患者生活方式方面应关注的问题，如注意休息，保持规律的作息，避免过度劳累和压力过大；适当参与一些有益的社交活动和娱乐活动，增强与家人、朋友、同事等的沟通并取得其支持；保持良好的饮食习惯，适当摄入富含维生素 B、镁、锌等营养素的食物；适量进行一些体育锻炼，如散步、跑步、游泳等；避免吸烟、饮酒或滥用药物等不良习惯。再次，规律的药物治疗也是必不可少的。全科医生应嘱患者不可随意自行停药，由于治疗该病的主要药物是抗抑郁药，尤其是三环类抗抑郁药，有一定的副作用和依赖性，因此，患者需要在全科医生的指导下，按时按量服用，并注意观察药物的疗效和不良反应。如出现不良反应，应立即停药并就医。

对于抑郁障碍的患者家属，由于抑郁障碍的自杀率较高，因此家属需要充分认识到抑郁障碍的危害，一旦发现患者情绪有问题时，应尽早就医和接受专业治疗，不要讳疾忌医。因此，作为患者的家属，要严密观察患者的病情变化，督促患者按时服药，定期门诊就诊，有病情变化时随时就医。

（三）转诊指征

1. 紧急转诊　患者目前有明确的自杀计划，比如计划跳楼并去楼顶踩点，囤积大量的药物，写遗书或购买大量活性炭等；近期已经实施过自杀行为。或者患者伴有严重躯体疾病，联合用药可能存在不良反应；患者服药后出现意识障碍、血压明显升高、大量出汗或肝功能异常等严重药物不良反应。作为全科医生，若患者出现上述情况，应积极进行紧急转诊。

2. 紧急处置　如果患者目前有强烈的自杀观念，或有明显的自罪自责，应告知家人务必加强看护，防范患者实施自杀行为。如果患者已出现自杀行为，可针对自杀行为做相应处理，比如止血、洗胃等。紧急处置后，应建议立即转诊至精神专科机构。

3. 普通转诊　患者出现以下情况，需要进行普通转诊：①出现多个抑郁症状，考虑有抑郁症可能，须明确诊断者；②两种抗抑郁药规范治疗 4 周症状改善不明显；③出现难以耐受的药物不良反应；④伴有人格障碍；⑤伴有多种躯体疾病；⑥治疗依从性差；⑦家庭支持系统差。

（占伊扬）

思考题

1. 请简述可能与抑郁障碍发生发展有关的病因及发病机制。
2. 请简述抑郁障碍的典型临床表现。
3. 请简述抑郁障碍的药物治疗原则。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

NOTES